Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO / IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE	
SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
UNIDAD ASISTENCIAL RESPONSABLE UNITAT ASSISTENCIAL RESPONSABLE	Servicio de Urgencia Hospitalaria
SERVICIO SERVEI	URGENCIAS
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	19/07/2025
FECHA Y HORA DE ALTA DATA I HORA D'ALTA	20/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT			
PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		Nº Hª CLÍNICA Nº Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	SEX2	F. NACIMIENTO D. NAIXIMENT	09/11/1938
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Datos generales del paciente / Dades generals del pacient

Procedencia / Procedència: PARTICULAR

Motivo de la atención / Motiu de l'atenció: .

Antecedentes / Antecedents: Niega alergias medicamentosas conocidas.

Antecedentes Respiratorios:
-Ex-fumadora desde hace mas de 40 años de 4 cig/dia.
-Tras viaje prolongado en coche a Alemania, TVP + TEP bilateral en Francia en 2016 y en 2022. En tratamiento actualmente con Rivaroxaban.
- TBC en la infancia (TAC del 2017 hallazgos compatibles con cambios post TBC).
- EPOC.
- Portadora de VMNI por SAOS (BiPAP puesta en Navarra).
- Portadora de OCD 2 lpm de rescate

Antecedentes personales:
- Dislipemia.
- Ictus vertebrobasilar en septiembre 2021.
- Deterioro cognitivo desde ingreso por ictus vertebrobasilar en estudio por Neurología.
- Elevación hemidiafragma derecho.
- Insuficiencia tricuspídea moderada.

Tratamiento habitual:
-CALCIFEDIOL AMPOLLAS BEBIBLES 0.266 MG/1.5 ML DE 1.5 ML.
-ABSORBENTE INC ORINA DIA ANAT
-HALOPERIDOL 2 MG EN 1 ML / 1 FRASCO SOL GOTAS DE 30 ML.

Social: vive con el marido. Barthel 80.

Marido Pierre tlf 667493227

Enfermedad o proceso actual / Malaltia o procés actual: Mujer de 86 años que acude por sensación disneica, fatiga que aumenta al caminar desde hoy por la tarde, al usar su propio puloximetro se encuentra SpO2 82%. No refiere fiebre termometrado en su casa.
El marrido rechaza realizar la prueba de COVID-19 ni el Gripe.

Exploración física / Exploració física: Constantes- Sat. O2: 87 % (Sin Oxígeno); TA: 141/75 mmHg; Tª: 37.6 ºC ºC (Timpánica); FC: 69 lat/min (Rítmica); Sat. O2: 87 % (Sin Oxígeno);
Buen estado general, consciente y orientada, nomocoloreada y normohidratada. Eupneica en reposo.
Auscultación Pulmonar: murmullo vesicular conservado, hipofonesis basal derecha+crepitaciones. No trabajo respiratorio.
Auscultación cardíaca: Tonos ritmicos, sin soplos.

Exploraciones complementarias / Exploracions complementaries:

HEMOSTASIA BÁSICA
HEMOSTASIA BÁSICA
T. PROTROMBINA 10,8 seg (9,0 - 13,0)
INDICE DE QUICK 100,0 % (70,0 - 120,0)
INR 0,94

Evolución / Evolució:

(0,80 - 1,20)
TP RATIO 0,94
(0,80 - 1,20)
TTPA RATIO 0,88
(0,80 - 1,25)
T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV
27,7 seg (25,1 - 38)
FIBRINOGENO * 556,00
mg/dL (200,00 - 400,00)
T.TROMBINA 21,00 seg
(18.4 - 27.5)
DIMEROS D * 2.583,00
ng/mL (0 - 500)
Tiempo de trombina Ratio 0,91

HEMOGRAMA
HEMATIES 4,40 x
10^6/µL (4,20 - 6,10)
HEMOGLOBINA 13,8 g/dL
(12,0 - 18,0)
HEMATOCRITO 40,7 %
(37,0 - 52,0)
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO
92,3 fL (80 - 94)
HBG CORPUSCULAR MEDIA *
31,3 pg (27,0 - 31,0)
CONC. HBG CORPUSCULAR MEDIA
33,9 g/dL (33,0 - 37,0)
RDW-CV 13,5 %
(11,6 - 14,5)
LEUCOCITOS 9,70 x
10^3/µL (4,80 - 10,80)
NEUTROFILOS 5,80 x
10^3/µL (1,90 - 8,00)
LINFOCITOS 2,50 x
10^3/µL (0,90 - 5,20)
MONOCITOS * 1,20 x
10^3/µL (0,16 - 1,00)
EOSINOFILOS 0,10 x
10^3/µL (0,00 - 0,80)
BASOFILOS 0,10 x
10^3/µL (0,00 - 0,20)
NEUTROFILOS % 59,9 %
(40,0 - 70,0)
LINFOCITOS % 26,3 %
(19,0 - 48,0)
MONOCITOS % * 11,9 %
(3,4 - 9,0)
EOSINOFILOS % 1,3 %
(0,0 - 7,0)
BASOFILOS % 0,6 %
(0,0 - 1,5)
PLAQUETAS 235 x
10^3/µL (130 - 400)

BIOQUIMICA SUEROS ANALCLIN
GLUCOSA * 116 mg/dL
(70 - 110)
UREA 37 mg/dL
(10.0 -- 50.0)
CREATININA * 0,95 mg/dL
(0,51 - 0,95)
FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI
* 53,85 ml/min/sup (60.00-200.0)
SODIO 142 mmol/L
(134-145)
POTASIO 4,52 mmol/L
(3.50-5.00)
CLORO * 108 mmol/L
(95-105)

PROTEINA C REACTIVA *
14,90 mg/L (1.00-10.0)
HORMONAS ANALCLIN
NT- PROBNP * 220 pg/mL
(20 - 125)

RX de tórax en proyección PA y lateral. Se compara con estudios previos.

Hallazgos:
Atelectasias laminares de predominio izquierdo.
Elevación del hemidiafragma derecha que condiciona un menor volumen del pulmón ipsilateral asi como desplazamiento de la silueta cardiaca hacia el lado izquierdo hallazgos ya visualizados en estudios previos.
Derrame pleural izquierdo. Seno costofrénico derecho pinzado.
Se visualiza un aumento de tamaño del mediastino superior con desplazamiento de la traquea hacia la derecha en relación con bocio con componente endotorácico ya estudiado en TC realizado en 2023.
Sin alteraciones significativas en las estructuras óseas visualizadas.
Sin otros hallazgos

Técnica: Angio-TC de arterias pulmonares con contraste intravenoso.
Se compara con estudios previos.
Estudio parcialmente artefactado por los movimientos respiratorios de la paciente durante su adquisición.

Hallazgos:
Se identifican defectos de repleción en arteria lobar de lóbulo inferior derecho así como en ramas segmentarias de lóbulo superior e inferior izquierdo compatibles con tromboembolismo pulmonar.
Atelectasias laminares en ambos campos pulmonares.
No se identifica reflujo de contraste a vena cava superior como signo de sobrecarga derecha. Cono de la arteria pulmonar de 25 mm.

No derrame pleural. Elevación del hemidiafragma derecho ya conocido.
Bocio endotorácico izquierdo.
Atrofia renal derecha.
Sin otros hallazgos a reseñar respecto estudios previos.

IC NEUMOLOGÍA

Avisan para valorar a paciente de 86 años institucionalizada con antecedentes de ictus vertebrovasilar y demencia. A nivel respiratorio, TEP bilateral crónico en tratamiento con Rivaroxabán (Familair refiere que actualmente ha dejado de tomárselo por voluntad propia). OCD 2lpm durante 16 horas diarias que NO USA. VMNI que NO USA. Acude con marido, con el que se realiza la anamnesis por estado basal de la paciente. Refiere aumento de disnea en los días previos, con desaturaciones presenciadas en domicilio. Estas desaturaciones vienen relacionadas la mayoria de veces por dormir la paciente en decúbito lateral izquierdo (elevación

diafragmática derecha). Además refiere polaquiuria y orinas de mal olor. Edemas en mmii, no otropnea ni DPN. No fierbe. No tos ni expecotración, no dolor torácico.

EF: AEG, cyO. Eupneica. SpO2 96% con GN 2.5lpm.
AP: Mvc.
MMII: Edemas bimaleolares bilaterales.

A nivel analítico, únicamente destaca elevación de Dímero D en contexto de TEP crónico ya conocido.
En Angio-TC, TEP bilateral en arteria lobar de lóbulo inferior derecho así como en ramas segmentarias de lóbulo superior e inferior izquierdo (Menor número de ramas con respecto a 2022).
En GA FiO2 21% con insuficiencia respiratoria parcial crónica (no agudizada).

PLAN: Por nuestra parte no presenta patología neumológica que precise de ingreso hospitalario. Ofrecemos alternativa de anticoagulante financiado por SNS (Dabigatran) que familiar rechaza; prefiere Rivaroxaban.
Recomendamos continuar tratamiento con Rivaroxaban 20mg cada 24 horas como venía realizando, así como continuar controles en Unidad de Trombosis del HPCS.
Recomiendo dormir en decúbito lateral derecho (Elevación diafragmática derecha), de cara a evitar disnea y desaturaciones nocturnas. Explico a familiar, que entiende y acepta.
Recomiendo iniciar tratamiento depletivo ambulatorio, así como valoración con V-Scan de posible valvulopatías que pueda justificar disnea. A decidir por médico responsable.

Se administra hidrocortisona combiprasal, budesonida con efecto favorable.
En resumen:
Paciente con EPOC, DISNEA mixta, TEP cronico, elevación de diafragma importante, portador de OCD domiciliaria acude por disnea que aumenta al esfuerzo fisico. La paciente refiere mejoría al administrar los broncodilatodores, valorado po parte del neumologo de guardia, pero se desestima para el ingreso a su cargo. Se decide alta con tratamiento ambulatorio.

Diagnóstico principal / Diagnòstic principal: DISNEA MULTIFACTORIAL

Diagnósticos secundarios / Diagnòstics secundaris:
TEP CRONICO
ELEVACION DIAFRAGMATICA DERECHA
DEMENCIA

Tratamiento al alta / Tractament a l'alta:
-Observación domiciliaria
-Mantener su tratamiento habitual
-OCD a 2 LPM segun necesidad
-RIVAROXABAN 20 MG / 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA. 1 COMPRIMIDO cada día durante 28 días.

-ATROVENT 20MCG/DOS 200 DOSIS 10ML SOLUCION INHALACION ENV A PRESION. 2 PULSACION cada 6 horas durante 25 días.

-FUROSEMIDA 40 MG / 30 COMPRIMIDOS. 1 COMPRIMIDO cada día durante 10 días.
-Explico signosde alarma, reconsultar si empeoramiento.

Circunstancias al alta / Circumstàncies a l'alta: MÉDICO DE CABECERA

Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

Responsable:

Firma digital / Signatura digital:

Sección / Secció: URGENCIAS

Fecha / Data:

Fecha creación / Data creació: 20/07/2025